BONUS 3

Šablony prezentace případu na vizitě

Struktura 60- a 120sekundové prezentace, 8 šablon podle typu případu, užitečné hotové věty na vizitu a 6 vzorových prezentací od začátku do konce.

Obsah

Jak tyto šablony používat

Kapitola 1 · 60sekundová prezentace

Kapitola 2 · 120sekundová prezentace

Kapitola 3 · 8 šablon podle typu případu

Kapitola 4 · Užitečné věty na vizitu

Kapitola 5 · 6 vzorových prezentací

Kapitola 6 · Závěrečná kontrola před prezentací

Další krok

NEŽ ZAČNETE

Jak tyto šablony používat

Dobrá prezentace případu je hlasovou podobou dobrého popisu: stejné pořadí, stejná srozumitelnost.

> *Na vizitě vám často nedělá potíže nedostatek znalostí, ale ztráta struktury. Šablona drží strukturu za vás; vy se soustředíte na nález.*

Prezentace odpovídá tomu, co používáte při psaní popisu **4krokové metody** je totožná:

KROK	EKVIVALENT V PREZENTACI
1 · PŘIPRAVTE	Pacient (věk, pohlaví), klinická otázka, vyšetření a protokol, technická kvalita.
2 · PROJDĚTE	Fráze «systematicky jsem zhodnotil(a)»; stručně uveďte, které oblasti jste prohlížel(a).
3 · POPIŠTE	Hlavní nález: správný termín, lokalizace, velikost, ohraničení; porovnání s předchozím vyšetřením. Poté přidružené nálezy.
4 · SHRŇTE	Jednovětý závěr popisu, diferenciální diagnóza, doporučení; komu a kdy byl akutní nález nahlášen.

Tři zlatá pravidla

1. **Nenechávejte závěr až na konec.** I při 60sekundové prezentaci uveďte v první větě klinickou otázku a v poslední větě jednoznačný závěr.
2. **Mluvte při ukazování obrazu.** Při popisu nálezu mějte na obrazovce otevřený příslušný řez a ukažte na něj.
3. **Nevymýšlejte si, co nevíte.** Říct: «Tímto si nejsem jistý(á), rád(a) bych to zhodnotil(a) společně se svým školitelem,» je projev profesionality.

> **Praxe**
>
> Každou šablonu si nejprve třikrát vyzkoušejte nahlas se stopkami. Do Cvičebnice si zapište svůj čas; cílem je dokončit 60sekundovou prezentaci za méně než 60 sekund.

KAPITOLA 1

60sekundová prezentace

Předání služby, vizita na chodbě, když zazní „řekněte to stručně“.

DOBA TRVÁNÍ	CO ŘEKNETE
0–10 s · Identifikace a klinická otázka	«[Věk]letá/letý [žena/muž], pro [potíže/klinická otázka] provedeno [vyšetření].»
10–15 s · Technika	«Vyšetření je v diagnostické kvalitě.» nebo «Hodnocení je limitováno z důvodu [limitace].»
15–40 s · Hlavní nález	«V [lokalizace] patrný [denzita/signál/echogenita] [nález], [ohraničení], [velikost]. Oproti předchozímu vyšetření [změna].»
40–50 s · Přidružené nálezy	«Doprovodný [nález] je / není přítomen. [Významný negativní nález] nezastižen.»
50–60 s · Závěr	«Závěrem nález odpovídá [diagnóza]; v diferenciální diagnóze [1–2 diagnózy]. [Doporučení]. [Hlášeno klinickému týmu].»

Tajemství stručnosti

Během 60 sekund uveďte pouze jeden hlavní nález a nanejvýš dva důležité negativní nálezy. Zbytek rozveďte pouze v případě dotazu.

KAPITOLA 2

120sekundová prezentace

Ranní vizita, seminář s kazuistikami, chvíle, kdy vám váš školitel řekne „popište to od začátku“.

DOBA TRVÁNÍ	CO ŘEKNETE
0–15 s · Identifikace a klinický stav	Věk, pohlaví, potíže a jejich trvání, relevantní anamnéza, klinická otázka.
15–25 s · Vyšetření a technika	Modalita, kontrastní látka a fáze (nebo sekvence), technická kvalita, dostupnost předchozích vyšetření.
25–35 s · Procházení	«Systematicky jsem zhodnotil(a) [oblasti].»
35–75 s · Hlavní nález	Přesný popis se správnou terminologií: lokalizace, velikost (ve dvou nebo třech rovinách), ohraničení, vnitřní struktura, sycení; porovnání.
75–90 s · Přidružené a negativní nálezy	Komplikace, doprovodné nálezy, významné negativní nálezy vztahující se ke klinické otázce.
90–110 s · Závěr a diferenciální diagnóza	Jednovětý závěr; proč v diferenciální diagnóze zvažujete na prvním místě právě toto.
110–120 s · Doporučení a komunikace	Doporučení dalšího vyšetření nebo kontroly; u akutního nálezu komu a kdy byl nahlášen.

Častá chyba

Při 120sekundové prezentaci se nejvíce času ztrácí u věty o systematickém procházení. Nevyjmenovávejte normální orgány jeden po druhém: stačí říct: «Ostatní parenchymatózní orgány jsou bez pozoruhodností»; důležité negativní nálezy relevantní ke klinické otázce však uveďte zvlášť.

KAPITOLA 3

8 šablon podle typu případu

Doplňte mezery, neměňte pořadí.

ŠABLONA 1

Akutní nález (jako krvácení, pneumotorax, volný plyn)

1. «Začínám urgentním nálezem: [nález].»
2. Pacient, klinická otázka, vyšetření.
3. Lokalizace, velikost a vliv nálezu (jako expanzivní chování, přetlakový posun, kolaps).
4. Komplikace a doprovodné nálezy.
5. «V [čas] informován [klinický tým/lékař].»

ŠABLONA 2

Normální vyšetření

1. Pacient, klinická otázka, vyšetření a technická kvalita.
2. «Při systematickém hodnocení jsem neshledal(a) patologický nález.»
3. Významné negativní nálezy vztahující se ke klinické otázce (např. „krvácení, expanze ani fraktura nejsou patrny“).
4. Pokud má vyšetření limitace, uveďte je (např. časná ischémie nemusí být na nativním CT patrná).
5. V případě potřeby doporučení.

ŠABLONA 3

Expanze / léze

1. Pacient, klinická otázka, vyšetření a postkontrastní fáze.
2. Lokalizace, velikost, ohraničení, vnitřní struktura a sycení léze.
3. Vztah k okolním strukturám, známky invaze.
4. Lymfatické uzliny a vzdálené nálezy.
5. Diferenciální diagnóza (počínaje nejpravděpodobnější) a doporučení dalšího vyšetření.

ŠABLONA 4

Infekce / zánět

1. Pacient, klinický stav (horečka, bolest, případně laboratorní výsledky), vyšetření.
2. Hlavní zánětlivý nález: lokalizace, rozsah.
3. Komplikace: absces, perforace, obstrukce, šíření.
4. Diferenciální diagnóza.
5. Doporučení (zda je přítomna kolekce vhodná k drenáži, zda je nutná kontrola).

ŠABLONA 5

Trauma

1. Pacient, mechanismus úrazu, vyšetření.
2. Nejzávažnější poranění jako první (život ohrožující nález).
3. Ostatní poranění v systematickém pořadí (od hlavy dolů nebo orgán po orgánu).
4. Důležité negativní nálezy (např. «bez známek aktivního úniku kontrastní látky»).
5. Hlášení a doporučení.

ŠABLONA 6

Kontrolní vyšetření (srovnávací)

1. Pacient, známá diagnóza, datum a modalita předchozího vyšetření.
2. Dnešní rozměr známé léze a její změna ve srovnání s předchozím nálezem (měřeno stejnou metodou).
3. Zda je přítomen nově vzniklý nález.
4. Celkové zhodnocení: regrese, stabilní stav, progrese.
5. Doporučení.

ŠABLONA 7

Kontrola kanyly / katétru / implantovaného zařízení

1. Pacient, vyšetření, kontrolovaný prostředek (prostředky).
2. Kde se nachází konec každého prostředku; je v očekávané poloze.
3. Komplikace související se zavedeným prostředkem (pneumotorax, malpozice, zalomení).
4. Změna oproti předchozímu RTG snímku.
5. Upozornění, pokud poloha není správná.

ŠABLONA 8

Náhodný nález

1. Nejprve klinická otázka a odpověď na ni.
2. «Dále byl náhodně zastižen [nález].»
3. Popis nálezu.
4. Doporučení podle klinické závažnosti a zvyklostí vašeho oddělení pro sledování.
5. Byl přítomen na předchozích vyšetřeních.

KAPITOLA 4

Užitečné fráze na vizitu

Správná formulace vyjadřuje správnou míru jistoty.

SITUACE	FORMULACE, KTEROU MŮŽETE POUŽÍT
Úvod	«[Věk]letá/letý [žena/muž]; pro [klinická otázka] provedeno [vyšetření].»
Technická limitace	«Hodnocení [oblasti] je limitováno pohybovými artefakty.»
Porovnání	«Ve srovnání s [vyšetření] ze dne [datum] [nález] co do [velikost/vzhled] [narostl/zmenšil se/beze změny].»
Předchozí vyšetření není k dispozici	«Předchozí vyšetření k porovnání není k dispozici.»
Vysoká jistota	«... v korelaci s / odpovídá...»
Střední míra jistoty	«Svědčí pro...; v diferenciální diagnostice lze zvážit...»
Nízká míra jistoty	«... nelze vyloučit.»
Důležitý negativní nález	«Vzhledem ke klinické otázce ... nezastiženo.»
Doporučení	«Lze doporučit dovyšetření pomocí [vyšetření] k posouzení...»
Hlášení	«Nález byl v [čas] hlášen [příslušnému lékaři].»
Otázka, kterou neznáte	«Tímto si nejsem jistý(á); načtu si to a při zítřejší vizitě se k tomu vrátím.»
Pokud má váš školitel jiný názor	«Já jsem kvůli ... uvažoval(a) o ...; rád(a) bych se zeptal(a), jak hodnotíte nález ... vy.»
Když tlačí čas	«Stručně: odpovídá ..., nahlášeno .... Přejete si, abych ukázal(a) podrobnosti?»
Závěr	«Závěrem ...; doporučuji .... »

Výrazy, kterým je třeba se vyhnout

- «Asi tam něco je» — pojmenujte nález a jeho lokalizaci.
- «Vypadá to normálně» — buď je nález v normě, nebo popište limitaci.
- «Mírný», «výrazný» (bez rozměru) — uveďte rozměry.
- «Nádor» (bez histologické verifikace) — říkejte «expanze» nebo «ložisková léze».
- U MR „denzita“, u UZ „opacita“ — používejte terminologii příslušné modality.

KAPITOLA 5

6 vzorových prezentací

Všechny případy jsou fiktivní; byly vytvořeny pouze pro demonstraci struktury prezentace.

PŘÍKLAD 1 · 60 SEKUND · ŠABLONA 1

Posttraumatické CT mozku

«Začínám urgentním nálezem: **akutní subdurální hematom**.

Dvaasedmdesátiletý muž, po pádu doma provedeno nativní CT mozku pro poruchu vědomí. Vyšetření je v diagnostické kvalitě.

Podél levé frontoparietální konvexity, paralelně s vnitřní laminou kalvy, je patrná srpkovitá hyperdenzní extraaxiální kolekce. Přítomna je komprese levé postranní komory a posun středočárových struktur doprava.

V kostním okně nenacházím frakturu. Doprovodné parenchymové krvácení není patrno.

Závěrem nález odpovídá akutnímu subdurálnímu hematomu s expanzivním chováním. Nález byl v 03:10 nahlášen lékaři urgentního příjmu.»

PŘÍKLAD 2 · 60 SEKUND · ŠABLONA 7

RTG hrudníku na JIP

«Pětašedesátiletá žena, po intubaci proveden bedside AP rentgenový snímek hrudníku ke kontrole polohy kanyly. Přítomna mírná rotace, k hodnocení dostatečné.

Konec endotracheální kanyly je těsně nad úrovní kariny; distálněji, než je na našem oddělení obvyklé. Konec pravostranného jugulárního centrálního žilního katétru je v úrovni horní duté žíly. Nazogastrická sonda dosahuje pod bránici.

Pneumotorax není patrný. Oproti předchozímu rentgenovému snímku bez nové konsolidace.

Závěrem je endotracheální kanyla uložena distálně; doporučeno zvážení povytažení. Hlášeno lékaři JIP.»

PŘÍKLAD 3 · 120 SEKUND · ŠABLONA 4

Bolest v pravém dolním kvadrantu, CT břicha

«Osmadvacetiletý muž, přichází se dva dny trvající bolestí v pravém podbřišku a teplotou; klinická otázka: akutní apendicitida. Provedeno kontrastní CT břicha a pánve v portovenózní fázi; předchozí vyšetření není k dispozici. Vyšetření je v diagnostické kvalitě.

Břicho jsem zhodnotil systematicky: volný plyn, parenchymatózní orgány, střeva, cévy a pánev.

Apendix má zvětšený kalibr, zesílenou a sytící se stěnu. V luminu je přítomno hyperdenzní ložisko odpovídající apendikolitu. V periapendikulárním tuku je patrné prosáknutí a malé množství volné tekutiny.

Nezjistil jsem žádnou kolekci odpovídající abscesu ani volný plyn. Stěna terminálního ilea a céka je bez pozoruhodností. Pravá ledvina a průběh močovodu jsou v normě, konkrement nebyl patrný.

Závěrem **nekomplikovaná akutní apendicitida** odpovídá. V diferenciální diagnóze lze zvážit cékální divertikulitidu a terminální ileitidu, nález je však centrován na apendix.

Nález byl sdělen rezidentovi všeobecné chirurgie.»

PŘÍKLAD 4 · 120 SEKUND · ŠABLONA 3

Plicní expanze na CT hrudníku

«Osmašedesátiletý muž, přichází s dlouholetou anamnézou kouření a tříměsíčním kašlem; pro nález opacity na RTG hrudníku bylo provedeno kontrastní CT hrudníku. K porovnání je k dispozici pouze RTG hrudníku starý jeden měsíc.

Provedl jsem systematické zhodnocení v plicním a mediastinálním okně.

V horním laloku pravé plíce je patrná solidní expanze nepravidelných a spikuliformních kontur s heterogenním sycením. Expanze odpovídá opacitě na rentgenovém snímku. Je podezření na propagaci k pleuře; invaze do hrudní stěny není zjevná.

V pravé hilové a dolní paratracheální oblasti jsou přítomny zvětšené lymfatické uzliny. V levé plíci nenacházím noduly. Zobrazené nadledviny i játra jsou obvyklého vzhledu; na skeletu nejsou patrné lytické léze.

Závěrem **svědčící pro primární plicní malignitu** expanze a hilová i mediastinální lymfadenopatie. K bioptickému ověření a stagingu je doporučeno další došetření.

Popis bych rád definitivně uzavřel se svým školitelem.“

PŘÍKLAD 5 · 60 SEKUND · ŠABLONA 2

Bolest hlavy, normální CT mozku

«Čtyřicetiletá žena, pro týden trvající cefaleu provedeno nativní CT mozku. Vyšetření je v diagnostické kvalitě.

Při systematickém hodnocení nenacházím patologický nález.

Krvácení, expanzivní chování ani posun středočárových struktur nejsou patrny. Komorový systém i cisterny jsou obvyklé. Diferenciace šedé a bílé hmoty je zachována. V kostním okně bez patologie; vedlejší nosní dutiny jsou vzdušné.

Víme, že nativní CT má při zobrazení některých patologií své limity; pokud klinické podezření přetrvává, lze zvážit doplňující vyšetření po domluvě s ošetřujícím týmem.“

PŘÍKLAD 6 · 120 SEKUND · ŠABLONA 6

Sledování jaterní léze

«Pětapadesátiletá žena, po operaci pro malignitu tlustého střeva; provedeno kontrastní CT břicha v portovenózní fázi k dispenzarizaci známé solitární léze jater. Srovnáno s CT před šesti měsíci. Vyšetření je v diagnostické kvalitě.

Břicho jsem zhodnotil systematicky.

Známá hypodenzní léze v pravém jaterním laloku při měření stejnou metodou a ve stejném řezu jako při předchozím vyšetření velikostně regredovala. Ohraničení a vnitřní struktura léze se výrazně nezměnily.

V játrech nenacházím nové léze. Nález svědčící pro lymfadenopatii, ascites nebo peritoneální implantáty není patrný. V oblasti anastomózy bez zjevné patologie. V zobrazených plicních bazích nejsou patrné uzly.

Závěrem u známé jaterní léze **regrese velikosti**; žádná nová léze. Ve srovnání s předchozím vyšetřením lze hodnotit jako odpověď na léčbu.

Interval kontrolního vyšetření lze stanovit podle plánu klinického týmu.»

KAPITOLA 6

Poslední kontrola před prezentací

Vyhraďte si před vizitou 2 minuty.

Před každou prezentací

- [ ] Dokážu říct věk, pohlaví a klinickou otázku pacienta v jedné větě.
- [ ] Vyšetření, kontrastní fáze nebo sekvence a poznámka o technické kvalitě jsou připraveny.
- [ ] Otevřel(a) jsem předchozí vyšetření a porovnal(a) (nebo zaznamenal(a) jeho absenci).
- [ ] Řez zobrazující hlavní nález je připraven na obrazovce.
- [ ] Pro hlavní nález používám správný termín (denzita / signál / echogenita).
- [ ] Mám připraveny alespoň dva významné negativní nálezy ke klinické otázce.
- [ ] Jednovětý závěr popisu a diferenciální diagnóza jsou připraveny.
- [ ] Pokud je přítomen akutní nález, vím, komu a kdy byl nahlášen.
- [ ] Prezentaci jsem si jednou v duchu vyzkoušel(a) se stopkami.

Zlaté pravidlo

Jediné, co vašemu školiteli z vizity utkví v paměti, je vaše poslední věta. Závěr popisu si napište předem a řekněte jej slovo od slova.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní si vyberte případ ze 100 praktických případů a s použitím vhodné šablony z šablon 1–8 předveďte 60sekundovou prezentaci se stopkami.

K předchozí přípravě otázek, které mohou při prezentaci padnout **300 otázek na vizitu a k ústní zkoušce**přejděte na.